מחברת שאלות תרגול — שלב ב'

פסיכיאטריה של הילד והמתבגר

53 שאלות בפורמט הבחינה · לפי שבועות הלימוד · מועד הבחינה 25 בנובמבר 2026

כל שאלה היא בפורמט שלב ב': וינייטה קלינית או שאלת "דון/תאר/הסבר" עם תת-שאלות פתוחות. ענה/י בעל-פה או בכתב, ואז בדוק/י מול מפתח נקודות המפתח שבסוף המחברת.

שבוע 1 — יסודות: נוירואנטומיה, נוירוטרנסמיטרים, התפתחות מוקדמת

דון **שבוע 1 · שאלה 1**

דון/י בתפקיד המיוחד של הקורטקס הפרה-פרונטלי (PFC) בילדים ובמתבגרים.

- מהו תפקידו בתפקודים ניהוליים (executive functions)?
- כיצד קשור להתפתחות דחיית סיפוקים והתנהגות במתבגר?
- מהו הקשר להפרעות פסיכיאטריות כמו ADHD?

דון **שבוע 1 · שאלה 2**

תאר/י את הצרבלום (המוח הקטן) ואת הקשר שלו לפסיכיאטריה.

- מהם תפקידיו המוטוריים והקוגניטיביים?
- מהו הקשר להפרעות פסיכיאטריות?

וינייטה **שבוע 1 · שאלה 3**

פעוטה בת 4, גן חובה. ההורים שואלים על התפתחות תקינה לגילה.

- תאר/י את אבני הדרך התקינות בגיל הגן (מוטורי, שפה, קוגניטיבי, משחק).
- מהו שלב המשחק האופייני ומה חשיבותו ההתפתחותית?

דון **שבוע 1 · שאלה 4**

הסבר/י את מערכת הנוראדרנרגית (locus coeruleus) ואת הרלוונטיות שלה בפסיכיאטריה של הילד.

- מהו מקור העצבוב הנוראדרנרגי העיקרי?
- מהו תפקידו בעוררות, קשב וסטרס?
- אילו תרופות פועלות דרך מערכת זו?

שבוע 2 — התפתחות, התקשרות, טמפרמנט, עקרונות פרמקולוגיה, ADHD, אוטיזם

דון **שבוע 2 · שאלה 1**

טמפרמנט בגיל הרך.

• מהם מרכיבי הטמפרמנט והסוגים העיקריים (לפי Thomas & Chess)?
• מהו הקשר בין טמפרמנט לפסיכופתולוגיה?
• מהו מושג ה-'goodness of fit'?

שבוע 2 · שאלה 2

ילד בגיל החביון אובחן כסובל מהפרעה על הרצף האוטיסטי (בעבר PDD-NOS).

• אילו קריטריונים ישפיעו על הפרוגנוזה?
• התייחס/י למושג Theory of Mind והשפעתו על היכולות ועל הפרוגנוזה.
• מהו המהלך האפשרי בגיל ההתבגרות?
• מהם סוגי הטיפול התרופתי לסימפטומים השונים?

שבוע 2 · שאלה 3

ילד בן 7 עם אבחנת ADHD; ההורים מתלבטים לגבי טיפול תרופתי וחוששים מתופעות לוואי.

• מהו ההבדל במנגנון ובפרופיל בין סטימולנטים ללא-סטימולנטים?
• אילו תופעות לוואי תסביר להורים ומה תנטר?
• מתי תעדיף/י לא-סטימולנט?

שבוע 2 · שאלה 4

אבחנה ואבחנה מבדלת בגיל הינקות.

• מהי שיטת הסיווג DC:0-5 ('אפס עד שלוש') ובמה ייחודה?
• מהי חשיבות ציר הפרעות הקשר הורה-תינוק?

שבוע 3 — מוגבלות שכלית, לקויות למידה, טיקים, סינדרומים, דיכאון, נוגדי דיכאון

שבוע 3 · שאלה 1

ילד בן 8 בכיתה ג' עם קושי ספציפי מתמשך בקריאה (דיוק, שטף, הבנה) שאינו תואם את יכולתו הכללית.

• מהי האבחנה וכיצד נבדלת ממוגבלות שכלית?
• מהו תהליך ההערכה?
• מהן ההתערבויות?

שבוע 3 · שאלה 2

ילד בן 5 עם התפתחות שפה מאוחרת — אוצר מילים דל וקושי בהרכבת משפטים, אך הבנה ותקשורת חברתית שמורות.

• מהי האבחנה המבדלת?

• אילו בדיקות תבצע/י?
• מהי החשיבות של הבחנה מ-ASD?

זכייטה **שבוע 3 · שאלה 3**

ילד בן 6 עם מוגבלות שכלית קלה, פנים אופייניות, קפל אפיקנתלי, וקומת גוף נמוכה. ידוע על מום לב מלידה.

• מהי האבחנה הגנטית הסבירה?
• מהי התחלואה הרפואית והפסיכיאטרית הנלווית?
• מהו הסיכון לאורך החיים?

זין **שבוע 3 · שאלה 4**

נוגדי דיכאון מסוג SNRI ואטיפיים בילדים ובמתבגרים.

• מהו מנגנון הפעולה של SNRI לעומת SSRI?
• מהו מנגנון הבופרופיון ומתי הוא שימושי?
• מהו הייחוד של מירטזפין?

שבוע 4 — TCA/MAOI, DMDD, ביפולרי, ליתיום, מייצבי מצב רוח, חרדה

זכייטה **שבוע 4 · שאלה 1**

מטופל נטל מנת-יתר של תרופה נוגדת דיכאון תלת-טבעתית (TCA).

• מהם הסיכונים המרכזיים במנת-יתר של TCA?
• מדוע TCA נחשבים מסוכנים יחסית ל-SSRI?
• מהם עקרונות הניהול?

זין **שבוע 4 · שאלה 2**

הסבר/י את הסיכון והמניעה של תסמונת סרוטונין ואת האינטראקציה עם MAOI.

• מהם התסמינים?
• מדוע נדרש 'washout' בין SSRI ל-MAOI?

זכייטה **שבוע 4 · שאלה 3**

מתבגרת בת 16 עם התקפי פאניקה חוזרים ובלתי-צפויים והימנעות הולכת וגוברת ממקומות סגורים ומהסעות ציבוריות.

• מהי האבחנה המבדלת?
• מהו הטיפול מבוסס-הראיות (פסיכולוגי ותרופתי)?
• מהו מקומם של בנזודיאזפינים?

שבוע 4 · שאלה 4

פרט/י את מנגנון הפעולה ותופעות הלוואי של ולפרואט וקרבמזפין כמייצבי מצב רוח.

- מנגנון
- תופעות לוואי וניטור
- שיקולים בבנות בגיל הפוריות

שבוע 5 — פוביות, OCD וקשורות, PTSD, אבל, התעללות

שבוע 5 · שאלה 1

מתבגרת בת 15 מבלה שעות מול המראה, משוכנעת שאפה מעוות ופגום, נמנעת מיציאה חברתית ומחפשת ניתוח פלסטי.

- מהי האבחנה ולאיזו קבוצה היא שייכת?
- מהי ההבחנה מחרדה חברתית ומהפרעת אכילה?
- מהו הטיפול?

שבוע 5 · שאלה 2

ילדה בת 10 מושכת שיער מקרקפתה עד כדי קרחות, לרוב בזמן שעמום או מתח, ומרגישה הקלה לאחר מכן.

- מהי האבחנה?
- מהי ההבחנה מ-OCD?
- מהו הטיפול מבוסס-הראיות?

שבוע 5 · שאלה 3

ילד בן 4 שאומץ בגיל שנתיים לאחר הזנחה קשה במוסד. מגלה חברותיות מופרזת, ניגש לזרים ומוכן ללכת איתם ללא היסוס.

- מהי האבחנה וההבחנה מ-RAD?
- מהו הקשר להיסטוריית הטיפול המוקדם?
- מהו הטיפול?

שבוע 5 · שאלה 4

מודל ה-ACEs (Adverse Childhood Experiences) והשלכות הטראומה המוקדמת.

- מהו מודל ה-ACEs?
- מהן ההשלכות ארוכות-הטווח הרפואיות והנפשיות?
- מהי הרלוונטיות הקלינית?

שבוע 6 — התקשרות מופרעת, דיסוציאציה, סומטי, סכיזופרניה,

אנטיפסיכוטים

שבוע 6 · שאלה 1

ילדה בת 12 עם התקפים של 'איבוד תחושה' בגפיים וחוסר יכולת ללכת, שהופיעו לאחר אירוע מלחיץ. הבירור הנוירולוגי תקין ולא תואם מחלה מוכרת.

• מהי האבחנה המבדלת?
• כיצד נבדלת הפרעת המרה (conversion) מהעמדת פנים ומ-factitious?
• מהו הטיפול?

שבוע 6 · שאלה 2

מתבגר בן 17 בהתקף פסיכוטי ראשון, מבודד חברתית, עם ירידה תפקודית של חצי שנה ואפקט שטוח.

• מהם סמני ה-prodrome ומהי חשיבות ההתערבות המוקדמת?
• מהו הבירור הראשוני?
• מהם עקרונות הטיפול הראשוני והפרוגנוזה?

שבוע 6 · שאלה 3

אגוניסטים חלקיים לדופמין (אריפיפרזול, ברקספיפרזול, קריפרזין).

• מהו מנגנון האגוניזם החלקי ('dopamine stabilizer')?
• מהם היתרונות בפרופיל תופעות הלוואי?

שבוע 6 · שאלה 4

מתבגרת מדווחת על תחושת ניתוק מגופה ומהמציאות ('כאילו אני צופה בעצמי מבחוץ'), על רקע היסטוריית טראומה.

• מהי האבחנה המבדלת בין הפרעות דיסוציאטיביות?
• מהו הקשר לטראומה?
• מהם עקרונות הטיפול?

שבוע 7 — SGA מטבוליים, EPS, TD, NMS, קטטוניה, ECT

שבוע 7 · שאלה 1

מטופל על אנטיפסיכוט מתלונן על חוסר-מנוחה פנימי מתמשך, צורך לזוז, וקושי לשבת במקום — החל ימים ספורים לאחר העלאת מינון.

• מהי האבחנה?
• כיצד נבדלת מאגיטציה פסיכוטית או מהחמרת המחלה?
• מהו הטיפול?

ניסיון **שבוע 7 · שאלה 2**

מתבגר עם סכיזופרניה מפתח קיפאון מוטורי, מוטיזם, שמירת תנוחות (posturing) ו-waxy flexibility.

• מהי האבחנה?
• מהי בדיקת הסף (challenge) האבחנתית-טיפולית?
• מהו הטיפול, ומה יש להימנע ממנו?

דיון **שבוע 7 · שאלה 3**

תסמונת מטבולית באנטיפסיכוטים אטיפיים בילדים ובמתבגרים.

• מהם מרכיבי הניטור המטבולי?
• אילו תרופות בסיכון הגבוה והנמוך?
• מהי ההתערבות?

דיון **שבוע 7 · שאלה 4**

טיפולים סומטיים מעבר ל-ECT: rTMS, קטמין/אסקטמין.

• מהו rTMS ומהי התווייתו?
• מהו מנגנון הקטמין וייחודו בדיכאון עמיד ואובדנות?

שבוע 8 — שינה, הפרעות אכילה, הפרשה

ניסיון **שבוע 8 · שאלה 1**

מתבגר בן 15 עם ישנוניות-יתר בשעות היום, התקפי שינה פתאומיים, ו'אובדן טונוס שרירים' בזמן צחוק (קטפלקסיה).

• מהי האבחנה ומהו הממצא הפתופיזיולוגי?
• מהו הבירור?
• מהו הטיפול?

ניסיון **שבוע 8 · שאלה 2**

ילד בן 4 שאינו אוכל מגוון מזונות — נמנע מרוב המרקמים והצבעים, ללא דאגה לגבי משקל או צורת גוף, עם ירידה בצמיחה.

• מהי האבחנה וההבחנה מאנורקסיה?
• מהו הבירור?
• מהו הטיפול?

ניסיון **שבוע 8 · שאלה 3**

נערה בת 16 במשקל תקין, עם התקפי אכילה ואחריהם הקאות יזומות. בבדיקה: שחיקת אמייל השיניים ובלוטות רוק מוגדלות.

• מהי האבחנה?
• מהם הסיבוכים הרפואיים המרכזיים?
• מהו הטיפול מבוסס-הראיות?

שבוע 8 · שאלה 4

התפתחות השינה בילדים והשינוי במתבגר.

• כיצד משתנה ארכיטקטורת השינה עם הגיל?
• מהו ה-'phase delay' של המתבגר והשלכותיו?

שבוע 9 — שימוש בחומרים וגמילה

שבוע 9 · שאלה 1

מתבגר בן 17 מגיע למיון עם עוררות, אישונים מורחבים, טכיקרדיה, יתר לחץ דם ופרנויה לאחר מסיבה.

• מהי האבחנה המבדלת (שיכרון מאיזה חומר)?
• מהו הניהול האקוטי?
• מהם סיכוני השימוש הכרוני?

שבוע 9 · שאלה 2

מתבגר עם שימוש כבד בקנביס מדווח על ירידה במוטיבציה, בזיכרון ובהישגים, ולאחרונה חרדה ואפיזודה פסיכוטית קצרה.

• מהן ההשלכות הפסיכיאטריות של שימוש בקנביס במתבגר?
• מהו הקשר לפסיכוזה?
• מהו הטיפול בהפרעת שימוש?

שבוע 9 · שאלה 3

מטופל צעיר עם הפרעת שימוש באלכוהול מעוניין בטיפול תרופתי לתמיכה בהתנזרות.

• מהם שלושת התכשירים העיקריים ומנגנונם?
• מהם השיקולים בבחירה ביניהם?

שבוע 10 — הפרעות אישיות

שבוע 10 · שאלה 1

מתבגר בן 16 עם דפוס מתמשך של הפרת זכויות אחרים — תוקפנות, שקרים, גניבות, בריחות מהבית והיעדר חרטה. החל לפני גיל 10.

• מהי האבחנה בגיל זה, ומדוע לא ניתן לאבחן הפרעת אישיות אנטיסוציאלית?
• מהי המשמעות של 'specifier 'callous-unemotional?

• מהו הטיפול?

דין **שבוע 10 · שאלה 2**

הפרעות אישיות מקבוצה A (הקבוצה ה'מוזרה/אקסצנטרית').

• תאר/י את שלוש ההפרעות (פרנואידית, סכיזואידית, סכיזוטיפלית).
• מהו הקשר של הסכיזוטיפלית לספקטרום הסכיזופרני?

דין **שבוע 10 · שאלה 3**

הפרעות אישיות מקבוצה C (החרדה/נמנעת).

• תאר/י את הנמנעת, התלותית וה-OCPD.
• כיצד נבדלת הנמנעת מחרדה חברתית?

שבוע 11 — פורנזי, חוק, מגדר/מין, הפרעות התנהגות, אובדנות, פרינטלי

דין **שבוע 11 · שאלה 1**

כשירות ואחריות משפטית בפסיכיאטריה של הילד.

• מהו סטנדרט Dusky לכשירות לעמוד לדין?
• מהו מבחן M'Naghten לטענת אי-שפיות?
• מהי הרלוונטיות לקטינים?

ניסיונה **שבוע 11 · שאלה 2**

מתבגרת בת 15 עם פגיעה עצמית חוזרת (חתכים) שאינה מלווה בכוונה אובדנית, המתוארת כמפחיתה מתח רגשי.

• מהי ההבחנה בין NSSI לניסיון אובדני?
• מהם התפקידים (functions) של הפגיעה העצמית?
• מהו הטיפול?

ניסיונה **שבוע 11 · שאלה 3**

אם טרייה, שבועיים לאחר לידה, מובאת למיון עם בלבול, נדודי שינה קשים, אמונות מוזרות לגבי התינוק ותכנים פסיכוטיים.

• מהי האבחנה ומהי דחיפותה?
• מהם גורמי הסיכון?
• מהו הניהול?

שבוע 12 — פרינטלי/גריאטרי, נוירואנטומיה, נוירולוגיה קלינית

שבוע 12 · שאלה 1

ילד בן 7 לאחר חבלת ראש בינונית בתאונת דרכים. חודשים לאחר מכן: שינויי אישיות, אימפולסיביות, קשיי קשב וירידה בוויסות רגשי.

• מהן ההשלכות הפסיכיאטריות של TBI בילדים?
• אילו אזורי מוח פגיעים במיוחד ומה תפקידם?
• מהו הניהול?

שבוע 12 · שאלה 2

נערה בת 16 מתלוננת על תנועות לא-רצוניות של הידיים בשעות הבוקר, ולעיתים 'נפילת חפצים'. לאחרונה גם אירוע של פרכוס כללי.

• מהי האבחנה הסבירה?
• מה תצפה/י לראות ב-EEG?
• מהו הטיפול והפרוגנוזה?

שבוע 12 · שאלה 3

תינוק בן חודש נבדק עקב היקף ראש קטן (מתחת לאחוזון 2) שהיה קטן כבר מההריון ועולה באיטיות.

• מה חשוב בבדיקה?
• אילו בדיקות נוספות תרצה/י לבצע?
• מהי האבחנה המבדלת של מיקרוצפליה?

שבוע 12 · שאלה 4

פרט/י שלוש הפרעות נוירולוגיות בהן מופיעים סימנים פסיכיאטריים בולטים (פסיכוזה, דיכאון, מאניה, דמנציה).

• תן/י שלוש דוגמאות עם ההסתמנות הפסיכיאטרית האופיינית.
• מהי המשמעות הקלינית לאבחנה המבדלת?

שבוע 13 — נוירולוגיה אוטואימונית/מטבולית, חירום, ייעוץ-קישור, פסיכותרפיות

שבוע 13 · שאלה 1

ילד בן 8 עם הופעה פתאומית ודרמטית של טקסי OCD קשים וטיקים, יומיים לאחר דלקת גרון. בעבר תפקד תקין.

• מהי האבחנה שיש לשקול?
• מהו הבירור?
• מהו הטיפול?

שבוע 13 · שאלה 2

ילד עם מחלה כרונית (סוכרת נעורים) ואי-היענות לטיפול, מרובה אשפוזים, עם סימני דיכאון וקונפליקט משפחתי סביב הטיפול.

• מהו תפקיד הפסיכיאטר בייעוץ-קישור (C-L) במקרה זה?
• כיצד תתמודד/י עם אי-ההיענות?
• מהם השיקולים ההתפתחותיים?

שבוע 13 · שאלה 3

טיפול דיאלקטי-התנהגותי (DBT) והתאמתו למתבגרים.

• מהו הבסיס הדיאלקטי (קבלה מול שינוי)?
• מהם מרכיבי התוכנית?
• מהי ההתאמה הייחודית למתבגרים?

שבוע 13 · שאלה 4

טיפול ממוקד-טראומה בילדים (TF-CBT).

• מהם מרכיבי ה-TF-CBT (ראשי התיבות PRACTICE)?
• מהי חשיבות הנרטיב הטראומטי ומעורבות ההורים?

שבוע 14 — ראיון מוטיבציוני, מסגרות טיפול, טיפול משפחתי, תיאוריות פסיכודינמיות, EBP

שבוע 14 · שאלה 1

רצף מסגרות הטיפול (levels of care) בפסיכיאטריה של הילד.

• תאר/י את הרצף מאמבולטורי ועד אשפוז מלא.
• מהם הקריטריונים למעבר בין רמות?
• מהם עקרונות הטיפול המילייה?

שבוע 14 · שאלה 2

עקרונות הראיון המוטיבציוני (MI) ושלבי השינוי.

• מהם ארבעת התהליכים (engaging, focusing, evoking, planning)?
• מהם מיומנויות OARS?
• מהם שלבי השינוי של Prochaska & DiClemente?

שבוע 14 · שאלה 3

טיפול משפחתי ואימון הורים (Parent Management Training).

• מהם עקרונות ה-PMT ובאילו הפרעות הוא יעיל?
• מהו ההבדל בין גישה מבנית לגישה מערכתית בטיפול משפחתי?

דון **שבוע 14 · שאלה 4**

פסיכולוגיית העצמי של קוהוט (self psychology).

• מהם צורכי ה-selfobject (mirroring, idealizing, twinship)?
• מהי משמעות ההעברות המשקפת והאידיאליזציה בטיפול?

מפתח נקודות לתשובה

שבוע 1 — נקודות מפתח

שאלה 1: דון/י בתפקיד המיוחד של הקורטקס הפרה-פרונטלי (PFC) בילדים ובמתבגרים.
■ תפקודים ניהוליים: תכנון, עיכוב תגובה, זיכרון עבודה, גמישות קוגניטיבית
■ ה-PFC מבשיל אחרון (עד שנות ה-20 המוקדמות) — מסביר אימפולסיביות ונטילת סיכונים במתבגר
■ ADHD: תת-פעילות דופמינרגית/נוראדרנרגית ב-PFC → ליקוי בוויסות קשב וב-signal-to-noise
■ קשר גם לסכיזופרניה (תסמינים שליליים/קוגניטיביים)
מקור: Stahl Essential ch.11; סילבוס עמ' 49

שאלה 2: תאר/י את הצרבלום (המוח הקטן) ואת הקשר שלו לפסיכיאטריה.
■ מוטורי: קואורדינציה, שיווי משקל, כוונון תנועה
■ קוגניטיבי-רגשי: 'cognitive affective syndrome', מעורב בקשב, שפה וויסות רגשי
■ קשר ל-ASD ולסכיזופרניה (ממצאי הדמיה)
■ סימנים נוירולוגיים רכים
מקור: סילבוס עמ' 44, 49; כרטיסיות עמ' 283-285

שאלה 3: פעוטה בת 4, גן חובה. ההורים שואלים על התפתחות תקינה לגילה.
■ מוטורי: קפיצה על רגל אחת, ציור צורות פשוטות
■ שפה: משפטים, מובנת לזרים, אלפי מילים
■ קוגניטיבי (פיאז'ה): שלב פרה-אופרציונלי — אגוצנטריות, חשיבה מאגית
■ משחק: משחק סימבולי/דמיוני ומשחק חברתי-שיתופי — חיוני להתפתחות רגשית וחברתית
מקור: Dulcan ch.3; סילבוס עמ' 42; כרטיסיות עמ' 302-303

שאלה 4: הסבר/י את מערכת הנוראדרנרגית (locus coeruleus) ואת הרלוונטיות שלה בפסיכיאטריה של הילד.
■ Locus coeruleus — מקור עיקרי; מקרין נרחבות לקורטקס
■ תפקיד: עוררות (arousal), קשב, תגובת fight-or-flight, ויסות סטרס
■ רלוונטי ל-ADHD, חרדה, PTSD
■ תרופות: אטומוקסטין (NRI), אגוניסטים אלפא-2 (גואנפצין/קלונידין), SNRI, פראזוסין
מקור: Stahl Essential ch.6; כרטיסיות עמ' 281-282

שבוע 2 — נקודות מפתח

שאלה 1: טמפרמנט בגיל הרך.
■ סוגים: easy, difficult, slow-to-warm-up

■ מרכיבים: רמת פעילות, סדירות, גישה/נסיגה, יכולת הסתגלות, עוצמת תגובה, מצב רוח
■ טמפרמנט 'קשה' ו-behavioral inhibition מנבאים סיכון לחרדה והפרעות התנהגות
■ goodness of fit — התאמה בין טמפרמנט הילד לסביבה/הורות משפיעה על התוצאה

מקור: כרטיסיות עמ' 301; סילבוס עמ' 42-43

שאלה 2: ילד בגיל החביון אובחן כסובל מהפרעה על הרצף האוטיסטי (בעבר PDD-NOS).
■ מנבאי פרוגנוזה: רמת השפה עד גיל 5-6, רמת התפקוד האינטלקטואלי, חומרת התסמינים
■ Theory of Mind — יכולת לייחס מצבים מנטליים לאחר; ליקוי מסביר קשיים חברתיים ופרגמטיים
■ בהתבגרות: שיפור אפשרי בחלק, סיכון לדיכאון/חרדה, אתגרי מיניות ועצמאות
■ תרופתי (סימפטומטי): ריספרידון/אריפיפרזול לרגזנות ואגרסיה, SSRI לחזרתיות/חרדה, סטימולנטים ל-ADHD נלווה

מקור: Dulcan ch.8; סילבוס עמ' 45 (דוגמה מקורית)

שאלה 3: ילד בן 7 עם אבחנת ADHD; ההורים מתלבטים לגבי טיפול תרופתי וחוששים מתופעות לוואי.
■ סטימולנטים (MPH/אמפטמין): הגברת DA/NE ב-PFC, first-line, השפעה מהירה
■ לא-סטימולנטים: אטומוקסטין (NRI), אגוניסטים אלפא-2 — השפעה איטית, ללא פוטנציאל ניצול
■ תופעות לוואי סטימולנטים: ירידה בתיאבון והאטה בגדילה, נדודי שינה, עלייה בדופק/ל"ד, החמרת טיקים
■ העדפת לא-סטימולנט: קומורבידיות טיקים/חרדה, חשש מ-misuse, אי-סבילות לסטימולנט

מקור: Dulcan ch.34; Stahl C&A

שאלה 4: אבחנה ואבחנה מבדלת בגיל הינקות.
■ DC:0-5 — סיווג ייעודי להפרעות נפשיות בינקות ובגיל הרך
■ ייחוד: ציר להערכת קשר הורה-ילד (Relationship Disorders)
■ מדגיש הקשר התייחסותי-התפתחותי ולא רק סימפטום בילד
■ פרמטרים לבדיקת קשר הורה-ילד

מקור: סילבוס עמ' 43

שבוע 3 — נקודות מפתח

שאלה 1: ילד בן 8 בכיתה ג' עם קושי ספציפי מתמשך בקריאה (דיוק, שטף, הבנה) שאינו תואם את יכולתו הכללית.
■ Specific Learning Disorder עם ליקוי בקריאה (דיסלקסיה); ספציפי, בשונה ממש"ה הכללית
■ הערכה: מבחנים פסיכו-דידקטיים, פער בין הישג ליכולת, שלילת ליקוי חושי/הזדמנות לימודית
■ התערבות: הוראה מותאמת, התאמות והנגשה בבחינות, חינוך מיוחד לפי זכאות
■ קומורבידיות שכיחה עם ADHD

מקור: DSM-5-TR עמ' 35-100; Dulcan ch.9; כרטיסיות עמ' 157-159

שאלה 2: ילד בן 5 עם התפתחות שפה מאוחרת — אוצר מילים דל וקושי בהרכבת משפטים, אך הבנה ותקשורת חברתית שמורות.
■ DDx: הפרעת שפה (Language Disorder), ליקוי שמיעה, מש"ה, ASD, גמגום/הפרעת דיבור
■ בדיקות: אודיולוגיה, הערכת שפה/תקשורת, הערכה התפתחותית
■ ב-ASD יש גם ליקוי חברתי-תקשורתי והתנהגות חזרתית — כאן התקשורת החברתית שמורה
■ טיפול: ריפוי בדיבור, מעקב התפתחותי

מקור: DSM-5-TR עמ' 35-100; Dulcan ch.9; כרטיסיות עמ' 176-180

שאלה 3: ילד בן 6 עם מוגבלות שכלית קלה, פנים אופייניות, קפל אפיקנתלי, וקומת גוף נמוכה. ידוע על מום לב מלידה.
■ תסמונת דאון (טריזומיה 21)

■ רפואי: מומי לב, בעיות שמיעה/ראייה, תת-פעילות בלוטת התריס, לויקמיה
■ פסיכיאטרי: שכיחות מוגברת של ADHD, ASD, ובבגרות — סיכון מוגבר לאלצהיימר מוקדם
■ מעקב רב-מקצועי לאורך החיים

מקור: Dulcan ch.7; סילבוס עמ' 44; כרטיסיות עמ' 287-292

שאלה 4: נוגדי דיכאון מסוג SNRI ואטיפיים בילדים ובמתבגרים.
■ SNRI (ונלפקסין, דולוקסטין): עיכוב ספיגה חוזרת של סרוטונין ונוראדרנלין; ל"ד מוגבר במינון גבוה
■ בופרופיון (NDRI): דופמין/נוראדרנלין — ללא תופעות מיניות, מסייע ב-ADHD ובגמילה מעישון; מוריד סף פרכוס (זהירות בהפרעות אכילה)
■ מירטזפין: אנטגוניסט אלפא-2 ו-HT2/3-5 — מרגיע, מעורר תיאבון, שימושי בנדודי שינה וירידה במשקל

מקור: Stahl C&A; Stahl Essential ch.7; כרטיסיות עמ' 4-15

שבוע 4 — נקודות מפתח

שאלה 1: מטופל נטל מנת-יתר של תרופה נוגדת דיכאון תלת-טבעתית (TCA).
■ סיכונים: קרדיוטוקסיות (הרחבת QRS, הפרעות קצב), פרכוסים, אפקט אנטיכולינרגי, היפוטנשן
■ מסוכנים יותר: אינדקס טיפולי צר, קטלניות במנת-יתר — לכן זהירות במתבגר אובדני
■ ניהול: ניטור ECG, סודיום ביקרבונט להרחבת QRS, תמיכה

מקור: Stahl Essential ch.7; כרטיסיות עמ' 4-15

שאלה 2: הסבר/י את הסיכון והמניעה של תסמונת סרוטונין ואת האינטראקציה עם MAOI.
■ תסמונת סרוטונין: שינוי מצב הכרה, אי-יציבות אוטונומית, היפר-רפלקסיה וקלונוס, חום
■ מנגנון: עודף סרוטונין (שילוב תרופות סרוטונרגיות)
■ washout: יש להמתין (לרוב 2 שבועות; 5 שבועות לפלואוקסטין בשל ½T ארוך) בין SSRI ל-MAOI
■ מגבלה תזונתית (טיראמין) ב-MAOI — משבר יתר לחץ דם

מקור: Stahl Essential ch.7

שאלה 3: מתבגרת בת 16 עם התקפי פאניקה חוזרים ובלתי-צפויים והימנעות הולכת וגוברת ממקומות סגורים ומהסעות ציבוריות.
■ הפרעת פאניקה + אגורפוביה; DDx: היפרתירואידיזם, אסתמה, קרדיולוגי, שימוש בחומרים/קפאין
■ first-line: CBT (כולל interoceptive exposure) + SSRI
■ בנזודיאזפינים: לטווח קצר בלבד — סיכון תלות, קוגניציה, disinhibition בילדים; לא first-line
■ פסיכו-חינוך על מחזור הפאניקה

מקור: DSM-5-TR עמ' 262-215; Dulcan ch.15; כרטיסיות עמ' 59-64

שאלה 4: פרט/י את מנגנון הפעולה ותופעות הלוואי של ולפרואט וקרבמזפין כמייצבי מצב רוח.
■ מנגנון: השפעה על תעלות נתרן ו-GABA
■ ולפרואט: הפטוטוקסיות, טרומבוציטופניה, עלייה במשקל, PCOS; ניטור רמות ותפקודי כבד
■ קרבמזפין: אינדוקציה של CYP450 (אינטראקציות), היפונתרמיה, דיכוי מח עצם, סיכון SJS (HLA-B*1502)
■ טרטוגניות: ולפרואט — מומי צינור עצבי; להימנע בבנות בגיל הפוריות

מקור: Stahl Essential ch.7; Stahl C&A (valproate); Dulcan ch.36

שבוע 5 — נקודות מפתח

שאלה 1: מתבגרת בת 15 מבלה שעות מול המראה, משוכנעת שאפה מעוות ופגום, נמנעת מיציאה חברתית ומחפשת ניתוח פלסטי.

■ Body Dysmorphic Disorder — בקבוצת OCD וקשורות
■ בשונה מחרדה חברתית (חשש מהערכה כללית) — כאן עיסוק בפגם גופני נתפס; בשונה מ-ED — לא עיסוק במשקל/צורת גוף כללית
■ insight לרוב ירוד; סיכון אובדני מוגבר
■ טיפול: SSRI במינון גבוה + CBT/ERP; הימנעות מניתוחים

מקור: DSM-5-TR עמ' 263-294; כרטיסיות עמ' 90-91

שאלה 2: ילדה בת 10 מושכת שיער מקרקפתה עד כדי קרחות, לרוב בזמן שעמום או מתח, ומרגישה הקלה לאחר מכן.

■ טריכוטילומניה (Hair-Pulling Disorder) — קבוצת OCD וקשורות
■ בשונה מ-OCD: אין אובססיה מניעה; המשיכה מונעת מדחף ומביאה הקלה (דמוי-התמכרות)
■ טיפול (CBT first-line: Habit Reversal Training); ראיות מוגבלות ל-NAC ו-SSRI
■ לשלול גורם דרמטולוגי; אקסקוריאציה = מקבילה בעור

מקור: DSM-5-TR עמ' 263-294; כרטיסיות עמ' 92-94

שאלה 3: ילד בן 4 שאומץ בגיל שנתיים לאחר הזנחה קשה במוסד. מגלה חברותיות מופרזת, ניגש לזרים ומוכן ללכת איתם ללא היסוס.

■ Disinhibited Social Engagement Disorder
■ בשונה מ-RAD (נסיגה, מיעוט חיפוש נחמה) — כאן חברותיות לא-סלקטיבית וחוסר ריסון עם זרים
■ נובע מטיפול לא-עקבי/הזנחה מוקדמת; יכול להימשך גם לאחר שיפור בסביבה
■ טיפול: יציבות ורצף בטיפול, קשר עם מטפל עקבי, תמיכה במשפחה המאמצת

מקור: DSM-5-TR עמ' 295-328; כרטיסיות עמ' 109-110

שאלה 4: מודל ה-ACEs (Adverse Childhood Experiences) והשלכות הטראומה המוקדמת.

■ ACEs — חוויות ילדות שליליות (התעללות, הזנחה, תפקוד לקוי במשפחה)
■ קשר מינון-תגובה: יותר ACEs → סיכון מוגבר לדיכאון, PTSD, BPD, שימוש בחומרים, אובדנות
■ השלכות רפואיות: מחלות לב, סוכרת, תמותה מוקדמת (דרך סטרס כרוני וציר HPA)
■ רלוונטיות: איתור מוקדם, טיפול מודע-טראומה, מניעה

מקור: Dulcan ch.24; כרטיסיות עמ' 100-108

שבוע 6 — נקודות מפתח

שאלה 1: ילדה בת 12 עם התקפים של 'איבוד תחושה' בגפיים וחוסר יכולת ללכת, שהופיעו לאחר אירוע מלחיץ. הבירור הנוירולוגי תקין ולא תואם מחלה מוכרת.

■ Functional Neurological Symptom Disorder (conversion); DDx: מחלה נוירולוגית אמיתית, factitious, malingering
■ conversion — לא מכוון/לא מודע; factitious — מכוון ליצירת תפקיד חולה ללא רווח חיצוני; malingering — מכוון לרווח חיצוני
■ טיפול: הרגעה, פיזיותרפיה, CBT, טיפול בקומורבידיות (חרדה/דיכאון); הימנעות מבירורים מיותרים
■ 'la belle indifférence' לא אמין לאבחנה

מקור: DSM-5-TR עמ' 349-370; Synopsis ch.12

שאלה 2: מתבגר בן 17 בהתקף פסיכוטי ראשון, מבודד חברתית, עם ירידה תפקודית של חצי שנה ואפקט שטוח.

■ prodrome: נסיגה חברתית, ירידה תפקודית, תסמינים שליליים מוקדמים, 'אטנואציה' של תסמינים חיוביים; DUP (משך פסיכוזה לא מטופלת) קצר → פרוגנוזה טובה יותר
■ בירור: שלילת חומרים, מצב רפואי, אוטואימוני; הערכה פסיכיאטרית
■ טיפול: SGA + התערבות מוקדמת מקיפה (family, שיקום); חינוך על היענות
■ childhood-onset — פרוגנוזה קשה יותר

מקור: Dulcan ch.18; DSM-5-TR עמ' 101-138

שאלה 3: אגוניסטים חלקיים לדופמין (אריפיפרזול, ברקספיפרזול, קריפרזין).
- אגוניזם חלקי ל-D2: מייצב — פועל כאנטגוניסט כשיש עודף דופמין וכאגוניסט כשיש חוסר
- יתרון: פחות EPS, פחות עלייה בפרולקטין, פרופיל מטבולי נוח יחסית
- אריפיפרזול עלול לגרום אקתזיה; דווח על הפרעות שליטה בדחפים (הימור)
- שימושי גם כתוספת בדיכאון

מקור: Stahl Essential ch.5; Stahl C&A (aripiprazole)

שאלה 4: מתבגרת מדווחת על תחושת ניתוק מגופה ומהמציאות ('כאילו אני צופה בעצמי מבחוץ'), על רקע היסטוריית טראומה.
- Depersonalization/Derealization Disorder; DDx: Dissociative Identity Disorder, Dissociative Amnesia, פסיכוזה, פרכוס, שימוש בחומרים
- קשר חזק לטראומה מוקדמת ולניתוק כהגנה
- טיפול: פסיכותרפיה מודעת-טראומה, ייצוב, טיפול בקומורבידיות
- לשלול גורם רפואי/נוירולוגי

מקור: DSM-5-TR עמ' 329-348; כרטיסיות עמ' 217-221

שבוע 7 — נקודות מפתח

שאלה 1: מטופל על אנטיפסיכוט מתלונן על חוסר-מנוחה פנימי מתמשך, צורך לזוז, וקושי לשבת במקום — החל ימים ספורים לאחר העלאת מינון.
- אקתזיה — תופעת לוואי אקסטרה-פירמידלית שכיחה ולעיתים מוחמצת
- הבחנה: חוסר-מנוחה מוטורי סובייקטיבי הקשור זמנית לתרופה/מינון (בשונה מאגיטציה של פסיכוזה)
- חשיבות: אקתזיה קשורה למצוקה ואף לאובדנות
- טיפול: הפחתת מינון, פרופרנולול (בטא-בלוקר), בנזודיאזפין; מעבר ל-SGA בפרופיל נמוך

מקור: Dulcan ch.37; Stahl Essential ch.5

שאלה 2: מתבגר עם סכיזופרניה מפתח קיפאון מוטורי, מוטיזם, שמירת תנוחות (posturing) ו-waxy flexibility.
- קטטוניה — יכולה להופיע בסכיזופרניה, בהפרעות מצב רוח ובמצב רפואי
- מבחן לורזפאם (benzodiazepine challenge) — גם אבחנתי וגם טיפולי
- טיפול: בנזודיאזפינים (לורזפאם) first-line; ECT במקרים עמידים/חמורים
- להיזהר מאנטיפסיכוטים — עלולים להחמיר קטטוניה ולהעלות סיכון ל-NMS

מקור: DSM-5-TR עמ' 101-138; Dulcan ch.37

שאלה 3: תסמונת מטבולית באנטיפסיכוטים אטיפיים בילדים ובמתבגרים.
- ניטור: משקל/BMI, היקף מותניים, גלוקוז/HbA1c, פרופיל שומנים, ל"ד — בסיס ולאורך הטיפול
- סיכון גבוה: אולנזפין, קלוזאפין; נמוך: לורסידון, זיפרסידון, אריפיפרזול
- ילדים רגישים יותר לעלייה במשקל מהמבוגר
- התערבות: מעקב, שינוי אורח חיים, מעבר תרופה, שקילת מטפורמין

מקור: Stahl Essential ch.5; כרטיסיות עמ' 76-83

שאלה 4: טיפולים סומטיים מעבר ל-rTMS :ECT, קטמין/אסקטמין.
- rTMS — גירוי מגנטי חוץ-גולגולתי; מאושר לדיכאון עמיד; לא-פולשני, ללא הרדמה
- קטמין/אסקטמין — אנטגוניסט NMDA; השפעה אנטי-דיכאונית מהירה (שעות) ואנטי-אובדנית
- שיקולי בטיחות: ניצול לרעה, תופעות דיסוציאטיביות, ניטור
- מקום מוגבל/נחקר בקטינים

מקור: Synopsis ch.22; כרטיסיות עמ' 35-36

שבוע 8 — נקודות מפתח

שאלה 1: מתבגר בן 15 עם ישנוניות-יתר בשעות היום, התקפי שינה פתאומיים, ו'אובדן טונוס שרירים' בזמן צחוק (קטפלקסיה).

■ נרקולפסיה type 1 (עם קטפלקסיה); חוסר אורקסין/היפוקרטין (הרס נוירונים היפותלמיים)

■ בירור: polysomnography + MSLT (sleep latency קצר, SOREMPs), רמות אורקסין ב-CSF

■ טיפול: היגיינת שינה ותנומות מתוזמנות; מודפיניל/סטימולנטים לישנוניות; פיטוליסנט; SNRI/oxybate לקטפלקסיה

■ DDx: דום נשימה, דיכאון, הרגלי שינה לקויים

מקור: DSM-5-TR עמ' 407-476; Dulcan ch.22; כרטיסיות עמ' 208-216

שאלה 2: ילד בן 4 שאינו אוכל מגוון מזונות — נמנע מרוב המרקמים והצבעים, ללא דאגה לגבי משקל או צורת גוף, עם ירידה בצמיחה.

■ ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder)

■ בשונה מאנורקסיה — אין הפרעה בתפיסת הגוף או פחד מהשמנה; ההימנעות סנסורית/חשש מהיחנקות/חוסר עניין

■ בירור: שלילת גורם רפואי/אלרגי, הערכה תזונתית וגדילה; קשר ל-ASD

■ טיפול: התערבות התנהגותית-תזונתית, ריפוי בעיסוק, מעורבות משפחה

מקור: DSM-5-TR עמ' 371-398; כרטיסיות עמ' 111-132

שאלה 3: נערה בת 16 במשקל תקין, עם התקפי אכילה ואחריהם הקאות יזומות. בבדיקה: שחיקת אמייל השיניים ובלוטות רוק מוגדלות.

■ Bulimia Nervosa (משקל תקין/גבוה, התנהגויות מפצות)

■ סיבוכים: היפוקלמיה ו-alkalosis (הפרעות קצב), שחיקת אמייל, סימן Russell, קרעים בוושט, בלוטות רוק

■ טיפול: CBT-E (first-line), פלואוקסטין (ה-SSRI המאושר לבולימיה, במינון גבוה)

■ הערכת אובדנות

מקור: DSM-5-TR עמ' 371-398; Dulcan ch.19; כרטיסיות עמ' 111-132

שאלה 4: התפתחות השינה בילדים והשינוי במתבגר.

■ צרכי שינה יורדים עם הגיל; פעוט זקוק לתנומות

■ מתבגר: דחייה ביולוגית של השעון הצירקדי (עיכוב הפרשת מלטונין) → נטייה להירדם ולהתעורר מאוחר

■ התנגשות עם שעת התחלת בי"ס → חוסר שינה כרוני, השפעה על מצב רוח ותפקוד

■ היגיינת שינה, חשיפה לאור, מלטונין

מקור: Dulcan ch.22; כרטיסיות עמ' 208-216

שבוע 9 — נקודות מפתח

שאלה 1: מתבגר בן 17 מגיע למיון עם עוררות, אישונים מורחבים, טכיקרדיה, יתר לחץ דם ופרנויה לאחר מסיבה.

■ שיכרון סטימולנטים (אמפטמין/קוקאין/MDMA): אישונים מורחבים, סימפתומימטי, פרנויה/פסיכוזה

■ DDx: הלוצינוגנים, שיכרון קפאין, מצב רפואי

■ ניהול: סביבה רגועה, בנזודיאזפינים לאגיטציה, קירור/ניטור לב, הידרציה

■ כרוני: פסיכוזה, ירידה במשקל, פגיעה קרדיווסקולרית, סיכון התמכרות

מקור: DSM-5-TR עמ' 543-666; כרטיסיות עמ' 192-202

שאלה 2: מתבגר עם שימוש כבד בקנביס מדווח על ירידה במוטיבציה, בזיכרון ובהישגים, ולאחרונה חרדה

ואפיזודה פסיכוטית קצרה.
■ השלכות: הפרעת שימוש, ליקוי קוגניטיבי, 'תסמונת אמוטיבציונית', חרדה
■ פסיכוזה: שימוש מוקדם ותכוף מעלה סיכון לסכיזופרניה (במיוחד עם פגיעות גנטית, THC גבוה)
■ תסמונת גמילה: עצבנות, נדודי שינה, ירידה בתיאבון
■ טיפול: התערבות פסיכו-סוציאלית (MI, CBT); אין תרופה מאושרת ספציפית
מקור: DSM-5-TR עמ' 543-666; כרטיסיות עמ' 192-202

שאלה 3: מטופל צעיר עם הפרעת שימוש באלכוהול מעוניין בטיפול תרופתי לתמיכה בהתנזרות.
■ נלטרקסון — אנטגוניסט אופיואידי; מפחית חשק ותגמול (זהירות בכבד/אופיואידים)
■ אקמפרוסט — מודולציה גלוטמטרגית/GABA; בטוח בכבד, מתאים לאי-ספיקת כבד
■ דיסולפירם — מעכב אלדהיד-דהידרוגנאז → תגובה לא-נעימה עם אלכוהול; דורש מוטיבציה והיענות גבוהה
■ בחירה לפי מטרה, כבד, היענות
מקור: Stahl Essential ch.13; כרטיסיות עמ' 192-202

שבוע 10 — נקודות מפתח

שאלה 1: מתבגר בן 16 עם דפוס מתמשך של הפרת זכויות אחרים — תוקפנות, שקרים, גניבות, בריחות מהבית והיעדר חרטה. החל לפני גיל 10.
■ Conduct Disorder (childhood-onset); ASPD רק מגיל 18
■ מנבא (specifier 'with limited prosocial emotions' (callous-unemotional): חוסר אמפתיה/חרטה — פרוגנוזה קשה יותר וקשר ל-ASPD עתידי
■ טיפול: multisystemic therapy, אימון הורים, טיפול בקומורבידיות (ADHD); אין תרופה ספציפית
■ childhood-onset — פרוגנוזה קשה מ-adolescent-onset
מקור: DSM-5-TR עמ' 521-542; Dulcan ch.11; כרטיסיות עמ' 42-44

שאלה 2: הפרעות אישיות מקבוצה A (הקבוצה ה'מוזרה/אקסצנטרית').
■ פרנואידית: חשדנות ופרשנות עוינת מתמשכת
■ סכיזואידית: ניתוק חברתי ואפקט מצומצם, ללא רצון בקשרים
■ סכיזוטיפלית: אמונות מוזרות, חשיבה מאגית, עיוותי תפיסה, אי-נוחות חברתית
■ סכיזוטיפלית נחשבת חלק מהספקטרום הסכיזופרני (גנטי ופנומנולוגי)
מקור: DSM-5-TR עמ' 733-778; Synopsis ch.19

שאלה 3: הפרעות אישיות מקבוצה C (החרדה/נמנעת).
■ נמנעת: רגישות-יתר לביקורת ולדחייה, הימנעות חברתית מתוך תחושת נחיתות
■ תלותית: צורך מופרז שידאגו לה, קושי בהחלטות עצמאיות, פחד מנטישה
■ OCPD: פרפקציוניזם, שליטה ונוקשות (אגו-סינטוני, ללא אובססיות אמיתיות)
■ נמנעת מול חרדה חברתית: חפיפה רבה; הנמנעת חודרנית ומקיפה יותר ומאופיינת בתחושת נחיתות מתמשכת
מקור: DSM-5-TR עמ' 733-778; Synopsis ch.19

שבוע 11 — נקודות מפתח

שאלה 1: כשירות ואחריות משפטית בפסיכיאטריה של הילד.
■ Dusky: הבנה עובדתית ורציונלית של ההליך + יכולת לסייע להגנה
■ M'Naghten: בעת המעשה — לא ידע את טיב המעשה או שלא ידע שהוא פסול (מבחן קוגניטיבי)
■ בקטינים: מערכת נפרדת (חוק הנוער), דגש על שיקום; אחריות פלילית מגיל 12 בישראל
■ הבחנה בין כשירות (בהווה) לאחריות (בעת המעשה)
מקור: Dulcan ch.31; Synopsis ch.28

שאלה 2: מתבגרת בת 15 עם פגיעה עצמית חוזרת (חתכים) שאינה מלווה בכוונה אובדנית, המתוארת כמפחיתה מתח רגשי.

■ NSSI — פגיעה עצמית ללא כוונה אובדנית; ניסיון אובדני — עם כוונה למות
■ תפקידים: ויסות רגשי (הפחתת מתח), ענישה עצמית, תקשורת, ניתוק/דיסוציאציה
■ קשר ל-BPD, דיכאון, טראומה; NSSI מעלה סיכון עתידי לאובדנות
■ טיפול: DBT, זיהוי טריגרים ומיומנויות חלופיות; הערכת סיכון מתמשכת

מקור: Dulcan ch.26; כרטיסיות עמ' 16-20

שאלה 3: אם טרייה, שבועיים לאחר לידה, מובאת למיון עם בלבול, נדודי שינה קשים, אמונות מוזרות לגבי התינוק ותכנים פסיכוטיים.

■ פסיכוזה סב-לידתית — חירום פסיכיאטרי (סיכון לתינוק ולאם, כולל infanticide/אובדנות)
■ גורמי סיכון: היסטוריה של הפרעה ביפולרית (הקשר החזק ביותר), אפיזודה קודמת, חוסר שינה
■ ניהול: אשפוז לרוב, ייצוב (אנטיפסיכוט/מייצב), הערכת בטיחות התינוק, ECT במקרים חמורים
■ להבדיל מ-baby blues ומדיכאון סב-לידתי

מקור: Dulcan; Synopsis; כרטיסיות

שבוע 12 — נקודות מפתח

שאלה 1: ילד בן 7 לאחר חבלת ראש בינונית בתאונת דרכים. חודשים לאחר מכן: שינויי אישיות, אימפולסיביות, קשיי קשב וירידה בוויסות רגשי.

■ השלכות: שינויי אישיות, ADHD-like, אימפולסיביות, דיכאון/חרדה, אגרסיה
■ פגיעות: אונות פרונטליות וטמפורליות → דיס-אינהיביציה וליקוי בתפקודים ניהוליים
■ הערכה נוירו-פסיכולוגית; שיקום רב-מקצועי
■ ניהול סימפטומטי + תמיכה משפחתית וחינוכית

מקור: סילבוס עמ' 56; כרטיסיות עמ' 293-295

שאלה 2: נערה בת 16 מתלוננת על תנועות לא-רצוניות של הידיים בשעות הבוקר, ולעיתים 'נפילת חפצים'. לאחרונה גם אירוע של פרכוס כללי.

■ Juvenile Myoclonic Epilepsy (JME) — מיוקלונוס בוקר, לעיתים GTC, רגישות לחוסר שינה
■ EEG: polyspike-and-wave 4-6Hz, רגישות לפוטוסטימולציה
■ טיפול: ולפרואט יעיל (זהירות בבנות — טרטוגני; חלופות: לבטירצטאם, למוטריגין)
■ פרוגנוזה: שליטה טובה בתרופות אך לרוב טיפול לכל החיים

מקור: סילבוס עמ' 57 (דוגמה מקורית); כרטיסיות עמ' 293-295

שאלה 3: תינוק בן חודש נבדק עקב היקף ראש קטן (מתחת לאחוזון 2) שהיה קטן כבר מההריון ועולה באיטיות.

■ בדיקה: מדידות סדרתיות, היקפי ראש הורים, סימנים דיסמורפיים, בדיקה נוירולוגית והתפתחותית
■ בדיקות: הדמיה מוחית, זיהומי TORCH, סקר מטבולי, גנטיקה/כרומוזומים
■ DDx: מיקרוצפליה ראשונית (גנטית) מול שניונית (זיהום תוך-רחמי, חשיפה לאלכוהול/FASD, אנוקסיה)
■ השלכות: מש"ה, פרכוסים, עיכוב התפתחותי

מקור: סילבוס עמ' 58 (דוגמה מקורית)

שאלה 4: פרט/י שלוש הפרעות נוירולוגיות בהן מופיעים סימנים פסיכיאטריים בולטים (פסיכוזה, דיכאון, מאניה, דמנציה).

■ מחלת וילסון — שינויי אישיות, פסיכוזה, דיכאון (+טבעות KF)
■ הנטינגטון — דיכאון, אובדנות, פסיכוזה, דמנציה (+כוריאה)
■ אנצפליטיס אנטי-NMDA — פסיכוזה חדה, קטטוניה, פרכוסים
■ משמעות: בכל הסתמנות פסיכיאטרית 'לא טיפוסית' עם סימנים נוירולוגיים — לשלול גורם אורגני

מקור: סילבוס עמ' 58 (דוגמה מקורית); כרטיסיות עמ' 293-295

שבוע 13 — נקודות מפתח

שאלה 1: ילד בן 8 עם הופעה פתאומית ודרמטית של טקסי OCD קשים וטיקים, יומיים לאחר דלקת גרון. בעבר תפקד תקין.

- PANDAS / PANS — הופעה פתאומית של OCD/טיקים לאחר זיהום סטרפטוקוקלי
- בירור: תרבית גרון/ASO/anti-DNase B, שלילת גורמים אחרים
- טיפול: אנטיביוטיקה לזיהום פעיל, טיפול סטנדרטי ל-OCD (CBT/SSRI); אימונומודולציה במקרים נבחרים/מחקריים
- שנוי במחלוקת — לשמור על ספקנות אבחנתית

מקור: כרטיסיות עמ' 293-295

שאלה 2: ילד עם מחלה כרונית (סוכרת נעורים) ואי-היענות לטיפול, מרובה אשפוזים, עם סימני דיכאון וקונפליקט משפחתי סביב הטיפול.

- C-L: הערכת דיכאון/חרדה, הבנת מחסומי היענות, גישור בין המשפחה לצוות הרפואי
- אי-היענות: MI, פישוט משטר טיפולי, מעורבות מותאמת-גיל, טיפול בדיכאון
- התפתחותי: מתבגר שואף לעצמאות ולשליטה → מתן אחריות הדרגתית; קונפליקט הורי סביב טיפול
- מודל ביו-פסיכו-סוציאלי

מקור: Dulcan ch.48-49; כרטיסיות עמ' 296-299

שאלה 3: טיפול דיאלקטי-התנהגותי (DBT) והתאמתו למתבגרים.

- דיאלקטיקה: איזון בין קבלה (validation) לשינוי
- מרכיבים: טיפול פרטני + קבוצת מיומנויות + זמינות טלפונית + צוות מטפלים
- מיומנויות: mindfulness, סבילות למצוקה, ויסות רגשי, אפקטיביות בין-אישית
- התאמה למתבגרים: מודול 'walking the middle path', מעורבות המשפחה בקבוצת המיומנויות

מקור: כרטיסיות עמ' 203-207

שאלה 4: טיפול ממוקד-טראומה בילדים (TF-CBT).

- מרכיבים: פסיכו-חינוך, מיומנויות הרפיה, ויסות רגשי, עיבוד קוגניטיבי, נרטיב וחשיפה הדרגתית, מעורבות הורים, בטיחות עתידית
- נרטיב טראומטי: חשיפה מדורגת ומבוקרת מפחיתה הימנעות ועיוותים
- מעורבות הורים חיונית לתמיכה ולהכללה מחוץ לטיפול
- first-line ל-PTSD בילדים

מקור: Dulcan ch.16, ch.43; כרטיסיות עמ' 100-108

שבוע 14 — נקודות מפתח

שאלה 1: רצף מסגרות הטיפול (levels of care) בפסיכיאטריה של הילד.

- רצף: אמבולטורי → intensive outpatient → אשפוז יום → residential → אשפוז מלא
- קריטריונים: רמת סיכון (אובדנות/אלימות), חומרה תפקודית, כשל בטיפול ברמה נמוכה, צורך בהשגחה
- מילייה: מבנה יומי, קהילה טיפולית, token economy, ניהול משבר, שימוש מבוקר בבידוד/הגבלה
- תכנון שחרור ומניעת אשפוז חוזר

מקור: Dulcan ch.45-46

שאלה 2: עקרונות הראיון המוטיבציוני (MI) ושלבי השינוי.

- תהליכים: יצירת קשר → מיקוד → עוררות change talk → תכנון

■ OARS: שאלות פתוחות, אישור (affirmation), הקשבה משקפת (reflective), סיכום
■ שלבי שינוי: (pre-contemplation, contemplation, preparation, action, maintenance, (relapse
■ התאמת ההתערבות לשלב; 'גלגול עם ההתנגדות'

מקור: Dulcan ch.44

שאלה 3: טיפול משפחתי ואימון הורים (Parent Management Training).

■ PMT: מבוסס עקרונות התניה אופרנטית — חיזוקים חיוביים, גבולות עקביים, הפחתת חיזוק להתנהגות שלילית; יעיל ב-ODD/CD ו-ADHD
■ טיפול משפחתי מבני (Minuchin): גבולות, היררכיה ותת-מערכות במשפחה
■ מערכתי: המשפחה כמערכת; הסימפטום כמשרת תפקיד במערכת
■ מעורבות ההורים כסוכני שינוי

מקור: Dulcan ch.40-41; כרטיסיות עמ' 237-242

שאלה 4: פסיכולוגיית העצמי של קוהוט (self psychology).

■ selfobject: פונקציות שהאחר ממלא עבור לכידות העצמי
■ mirroring — הצורך להיראות ולהיות מוערך; idealizing — הצורך להתמזג עם דמות אידיאלית מרגיעה; twinship — הצורך בדמיון/שייכות
■ כשלים בהתפתחות → פגיעות נרקיסיסטית
■ בטיפול: העברה משקפת/אידיאליזציה; אמפתיה (introspection vicarious) ככלי מרכזי

מקור: כרטיסיות עמ' 262-265; סילבוס עמ' 19